Établissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI — AS · AES · ÉDUCATEURS

Crise d’épilepsie

Épilepsie connue ou non · adulte et enfant (EHPAD, MAS, FAM, IME)

15 IMMÉDIAT · crise **> 5 min** ; crises répétées sans reprise de conscience ; respiration anormale, lèvres bleues ; pas réveillé 30 min après ; **première crise** ; fièvre, choc à la tête, grossesse ; **3 crises en 1 h** ; blessure grave.

J’applique si

- Secousses, raideur, perte de contact ou de conscience : crise convulsive.
- Épilepsie connue ou non.

Je ne fais pas

- Mettre quoi que ce soit dans la bouche (doigts, objet, eau, comprimé), **hors Buccolam du PAI**.
- Retenir les membres de force ; déplacer pendant la crise, sauf danger.
- Donner une **2e dose** de Buccolam.
- Donner un « si besoin » sans validation de l’IDE ou du médecin.

J’agis

TOUT DE SUITE

1. Regarder l’**heure de début** (chronomètre).
2. Éloigner les objets, protéger la tête, desserrer le col, **ne pas retenir**. Fauteuil : freins, tête protégée.
3. Observer : raideur, secousses, un côté ou tout le corps ; reprise de conscience entre deux crises ?
4. À **5 min** de crise : **15**.

SI PAI / PROTOCOLE INDIVIDUEL

5. En même temps : midazolam buccal (**Buccolam**), dose et gestes du PAI, **une seule dose**, éducateur formé compris.

ENSUITE

6. Fin des secousses : **PLS** (côté gauche si grossesse), vérifier la respiration, rester auprès.
7. **Glycémie capillaire** (AS/AP), T°, SpO2 ; fièvre, choc à la tête, morsure de langue, perte d’urines ?
8. Rien par la bouche avant le **réveil complet** et une déglutition normale.

J’appelle l’IDE sans délai

- **Toute crise**, même courte et habituelle.
- Crises plus fréquentes ou différentes ; récupération lente.
- Traitement antiépileptique oublié, vomi ou refusé.
- **IDE injoignable** : médecin d’astreinte ; signe de gravité : **15**.

Je surveille et je trace

- Conscience et respiration jusqu’au réveil complet ; choc à la tête : « Traumatisme crânien ».
- Début, fin, description, gestes, médicament (heure, dose), récupération.
- Remettre aux secours le PAI et la **seringue vide**.

À retenir : Chronomètre en main : à 5 min, 15 (et Buccolam si le PAI le prévoit). Rien dans la bouche, ne pas retenir, PLS dès la fin des secousses.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road — Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : SRLF/SFMU/GFRUP, RFE état de mal épileptique (2018) ; EMA, RCP Buccolam (procédure II/0061, 21/10/2024) ; OMéDIT IDF/ARS IDF, Que dit la loi sur la PECM en ESMS handicap (01/2025) ; CASF art. L.313-26 ; ARS IDF/STARAQS, fiche crise convulsive (2023) ; DGSCGC, PSC1 (12/2023).

Réf. DOTR-AS-EPI | Version 3.0 – 11/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature